EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 91320
SERVICIO : UNIDAD EMERGENCIAS
FECHA : 2024-08-25 13:25:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SONIA SOLEDAD SEPULVEDA MELLA			RUN	: 13.793.853-7
F.Nac	: 06-09-1980	Edad	: 43 AÑOS, 11 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: SAN FERNANDO ZEMITA			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 932368955		
Fecha Ingreso	: 2024-08-25	Fecha Egreso	: 2024-08-25 13:25:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

PIELONEFRITIS AGUDA
DIABETES MELLITUS IR
COLELITIASIS

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON AM DE DMT2 IR, REFIERE DISURIA Y CAMBIO DE COLORACIÓN DE LA ORINA DESDE HACE 3 DÍAS.
AGREGA ESCALOFRÍOS DESDE ANOCHE./EX DE LAB: CREA 1,00, PCR 173,8, INR 1,25, NA 131, K ,80, LEU 30,40, ORINA INFECCIOSA./PERFIL HEPÁTICO ALTERADO,
SE REALIZA TAC DE ABDOMEN Y PELVIS. Colelitiasis sin signos tomográficos de colecistitis aguda. Estudio sin signos de nefritis, lo que no la descarta. Correlacionar con laboratorio. Daño hepático crónico. Quiste simple renal derecho.
AFEBRIL, LÚCIDA, EUPNEICA, HIDRATADA, PIEL Y MUCOSAS ICTÉRICAS
CARDIOPULMONAR N
ABDOMEN CON RHA +, BLANDO, DOLOR EN HIPOGASTRIO
PP + BILATERAL

SE CONVERSA CON PACIENTE Y ANTE SU ESTADO HEMODINAMICO ESTABLE, SE SUGIERE HODOM Y ACEPTA CONTINUAR EL TRATAMIENTO EN HOSPITALIZACION DOMICILIARIA

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR TRATAMIENTO EN DOMICILIO
CONTINUAR TTO EV X 7 DIAS
CONTROL DE EXAMENES EN 48 HORAS (RECUENTO GLOBULAR + PCR
RESCATAR UROCULTIVO PARA EVALUAR TRATAMIENTO

SE REALIZA IC PARA CIRUGIA PARA CONTROL POR HALLAZGO DE DIAGNOSTICO DE COLELITIASIS

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo: RELATIVO
2. Régimen: LIVIANO DM
3. REPOSO RELATIVO

4. REGIMEN LIVIANO HIPOSÓDICO: D 40 GR/Col 15-20/A 60 GR/Col 15 GR/Once 40 GR
5. HGT PRECOMIDAS
6. REFUERZO CON INSULINA CRISTALINA SEGÚN ESQUEMA
7. TRESIBA 40 UDS VSC 1 VEZ AL DÍA 10:00 H
8. NOVORAPID:
9. PRE-DESAYUNO : INYECTAR 6 UDS VSC 15 MINUTOS ANTES DE DESAYUAR
10. PRE-ALMUERZO: INYECTAR 10 UDS VSC 15 MIN ANTES DE ALMORZAR
11. PRE-ONCE: INYECTAR 6 UDS VSC 15 MINUTOS ANTES DE ONCE
12. METFORMINA 850 MG: 1 COMP DESPUES DE CADA COMIDA (3 VECES AL DIA)
13. CEFTRIAXONA 2 GR EV
14. FAMOTIDINA 40MG VO

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAC DE ABDOMEN Y PELVIS. Colelitiasis sin signos tomográficos de colecistitis aguda. Estudio sin signos de nefritis, lo que no la descarta. Correlacionar con laboratorio. Daño hepático crónico.
Quiste simple renal derecho.
EXAMENES DE LAB
Glicemia : 326 * mg/dl
Creatinina : 1,00 mg/dl
Fosfatasa Alcalina : 190 * U/L
Bilirrubina Indirecta : 1,12 * mg/dL
Bilirrubina Directa : 1,58 * mg/dL
Bilirrubina Total : 2,70 * mg/dL
ASAT/GOT : 35 U/L
ALAT/GPT : 55 * U/L
Gama GT : 405 * U/L
Clearence Calculado(MDRD) : 60,51 ml/min/1,73
Proteina C Reactiva : 173,8 * mg/L

LUIS MERA SALTOS
MEDICO TRATANTE
21510269-6

JEFE SERVICIO